

대장암 진단 첫 30일

결장암 · 직장암 · MMR 검사와 치료 순서

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 04

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

같은 대장암이라도 결장암과 직장암은 치료 순서가 다릅니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Colon Cancer / Rectal Cancer, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **△ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 결장암과 직장암, 그리고 MMR

30초 요약

- 결장암은 대개 수술 먼저, 직장암(특히 중·하부)은 수술 전 치료(항암·방사선) 먼저가 많습니다.
- MMR/MSI 검사는 모든 대장암 환자에게 권고됩니다. 결과가 치료 순서를 바꾸고, 유전(린치증후군) 선별에도 쓰입니다. **치료 시작 전에** 결과를 확인하세요.
- 용종 안의 암(조기암)은 내시경 절제로 끝낼 수도, 추가 수술이 필요할 수도 있습니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
선종, 고도이형성	전암병변	담당의 확인
용종 내 암(악성 용종)	내시경 절제 후 병리로 추가 수술 결정	6장
결장 선암	결장암	6장
직장 선암(대개 항문에서 약 15cm 이내, 최종 구분은 MRI 등으로)	직장암	7장
점액선암, 반지세포암	선암의 세부형	담당의 확인

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사·위치(결장/직장) 확인	Day 0-3
②	CT(흉부·복부·골반), 직장암은 골반 MRI, CEA	Day 3-14
③	MMR/MSI 결과	Day 7-14
④	수술 먼저 vs 수술 전 치료 먼저 결정	Day 8-21
⑤	가임력·장루 상담, 치료 준비	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 결장암인가요, 직장암인가요? 항문에서 몇 cm인가요?
2. MMR/MSI 검사는 했나요? 결과는 언제 나오나요?
3. 수술을 먼저 하나요, 다른 치료를 먼저 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- 배가 부풀고 방귀·대변이 멈추며 토함(장폐색)
- 많은 양의 혈변, 어지럼·실신
- 점점 심해지는 복통과 발열(천공·감염)
- 수술 후: 열·복통 악화·복부 팽만, 배액 색 변화, 상처 고름
- 장루 배출이 묽고 많아지며 어지러움·소변 감소(탈수)
- 한쪽 다리 부종, 갑작스러운 숨참·흉통(혈전)
- 항암 중 38℃ 이상 발열, 하루 4~6회 이상 설사, 흉통, 심한 입안 혈음으로 못 먹음
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 장폐색은 수술이나 스텐트가 필요할 수 있어 빨리 평가합니다.
2. 대량 출혈·어지럼은 응급입니다.
3. 수술 후 발열·복통은 연결 부위 누출 가능성이 있습니다.
4. 회장루는 수분 손실이 커서 탈수가 빨리 옵니다.
5. 암과 수술은 혈전 위험을 높입니다.
6. 항암 중 발열·심한 설사·홍통은 연락 기준입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과·위치 확인 ② 대장암 진료팀 예약 ③ 아이 계획이 있다면 메모(가임력 상담).

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지와 내시경 소견(위치·항문에서 거리)
- ☐ 대장항문외과·종양내과 진료 예약
- ☐ 아이 계획이 있거나 아직 정하지 못했다면 **치료 전 가임력 상담**을 첫 진료에서 요청 — 골반 방사선·항암은 생식 기능에 영향을 줄 수 있습니다

이번 주 할 일

- ☐ CT(흉부·복부·골반), 직장암은 골반 MRI, CEA 혈액검사
- ☐ 조영제 CT 전에 신장 질환, 당뇨약(메트포르민) 복용, 이전 조영제 알레르기가 있으면 미리 알리기
- ☐ MMR/MSI 검사 의뢰 확인
- ☐ 가족력(대장암·자궁내막암·위암 등) 정리 — 젊은 나이 진단·가족력이면 유전상담
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

- □ 변비·혈변·복통 기록

오늘 물어볼 질문

1. 조직검사와 내시경 소견을 설명해 주시겠어요?
2. 병기 검사는 무엇을 하나요?
3. 가임력 상담과 유전상담이 필요한가요?

4장. 병기와 검사

30초 요약: 병기는 장벽을 뚫은 깊이(T)·림프절(N)·전이(M)로 정합니다.
직장암은 **골반 MRI**로 종양과 주변 경계(직장간막)의 거리를 봅니다.

병기	쉬운 뜻	결장암 흔한 치료	직장암 흔한 치료
1기	장벽 안쪽	수술	수술(일부 국소절제)
2기	장벽을 뚫음, 림프절 없음	수술 ± 고위험이면 보조항암	수술 전 치료 → 수술
3기	림프절 전이	수술 → 보조항암	수술 전 치료(TNT) → 수술 또는 비수술 추적
4기	간·폐 등 전이	전신치료 ± 전이 절제	같음

- 판독지의 작은 결절·"불확정" 병변은 전이를 뜻하지 않을 수 있습니다. MRI나 추적 CT로 확인합니다. 간에 애매한 병변이 보이면 간 특이 조영제를 쓴 간 MRI가 개수·위치를 가장 정확히 보여 주는 검사로 쓰입니다.
- CEA는 진단보다 **추적에 쓰는 표지자**입니다. 정상이어도 암이 없는 것은 아닙니다.

직장암 MRI 단어장

표현	쉬운 말
mrT3, mrN1	MRI로 본 병기
MRF / CRM involved	직장간막 경계에 닿음 → 수술 전 치료가 중요
EMVI positive	장벽 밖 혈관 침범 → 재발 위험 요인
괄약근 침범	항문 보존 가능성과 관련

수술 후 병리에서 볼 것

검사한 림프절 수(대개 12개 이상 권장)와 전이 수, 절제면, 림프관·혈관·신경 침범, 종양 결절, MMR. 수술 전 치료 후에는 'yp' 병기와 반응 정도가 적힙니다.

5장. MMR/MSI와 유전, 바이오마커

30초 요약

- MMR 검사 결과지에는 네 가지 단백질(MLH1·PMS2·MSH2·MSH6) 이름이 나옵니다. 어떤 단백질이 없는지에 따라 **유전 상담 필요성**이 달라집니다.
- **dMMR/MSI-H**는 면역치료가 잘 듣는 경우가 많아 치료 순서가 바뀔 수 있습니다.
- 전이성에서는 **RAS(KRAS·NRAS)·BRAF·HER2**를 추가로 봅니다. ctDNA(혈액 종양 DNA)는 연구·선별적으로 쓰이며 아직 모든 환자의 표준 검사는 아닙니다.

린치증후군이 의심되면

1. 유전상담 → 2. 배선 유전검사 → 3. 변이가 확인되면 **가족 검사**(보통 성인이 된 뒤, 담당 의뢰진 확인) 린치증후군이면 대장 내시경을 더 자주 받고, 자궁내막·난소·위·요로 등 다른 장기 검진을 상의합니다.

가족에게 결과를 알리는 일은 부담이 큼니다. "나도 몰랐던 일이고, 알면 미리 검진할 수 있어서 말해 주는 거야"로 시작해 보세요.

바이오마커 기록: MMR _ (**없어진 단백질** _) · MSI _ · **RAS** _ · BRAF _ · **HER2** _ ·
CEA _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 결장암 치료

30초 요약

- 대부분 **수술(복강경·로봇 포함)로 해당 결장과 림프절을 함께 뺍니다.**
 - 3기는 **보조항암**: 재발 위험(T4·N2 여부)과 약 조합에 따라 **3개월 또는 6개월**로 정할 수 있습니다. 기간이 짧으면 손발 저림 위험이 줄어듭니다.
국내 안내 자료에는 6개월로만 적힌 경우가 많은데, 3개월은 주로 재발 위험이 낮은 3기에서 주사 + 먹는 항암제 조합을 쓸 때 논의됩니다.
 - 2기 고위험은 보조항암을 상의하고, **dMMR 2기**는 항암 이득이 적어 판단이 다릅니다.
 - **dMMR 결장암**에서 수술 전 면역치료가 새로 논의되고 있습니다(최신 근거·국내 허가·급여 확인 필요).
- 악성 용종: 내시경 절제 후 병리(깊이·절제면·림프관 침범·분화도)로 추가 수술 여부를 정합니다.
 - 장이 막힌 경우: 응급 수술 또는 스텐트로 먼저 길을 연 뒤 수술합니다.

보조항암 일정 예시

방식	일정	특징
주사 + 먹는 항암제 병용	3주 주기	포트 없이도 가능한 경우가 있음
주사 병용(2주 주기)	2일 연속 주입	포트·휴대용 펌프
먹는 항암제 단독	고령·저위험 등	손발 피부 변화 주의

손발 저림(옥살리플라틴) 자가 점검

- 투여 후 며칠은 **찬 음료·찬 물건**을 피하세요(목 조임·저림 유발).
- 저림이 단추 채우기·젓가락질에 영향을 주면 **다음 투여 전에** 알려 용량·일정을 조정합니다. | 주기 | 저림 0~10 | 일상 영향(□없음 □단추 □젓가락 □걷기) |
|---|---|---| 1 ||| 2 |||

7장. 직장암 치료

30초 요약

- 국소진행 직장암은 **수술 전 치료 → 수술**이 기본이며, 요즘은 항암과 방사선을 모두 수술 전에 하는 **전체 선행치료(TNT)**가 많습니다.
 - 방사선은 **1주(5회) 단기** 또는 **5~6주 장기** 방식이 있고, 일부는 방사선 없이 항암만 먼저 하기도 합니다.
 - 치료 후 종양이 사라진 **임상적 완전관해**면 수술 없이 촘촘히 추적하는 **비수술 추적(watch-and-wait)**을 상의할 수 있습니다.
 - **dMMR 직장암**은 수술 전 면역치료가 먼저 논의될 수 있고, 일부는 수술·방사선 없이 추적하는 길이 시행되고 있습니다(전문센터 상의·국내 허가·급여 확인 필요). 다만 2026년 현재 국내 건강보험 급여는 주로 전이성 dMMR 대장암의 1차 치료에 인정되고, 수술 전 면역치료는 임상연구나 개별 판단으로 제한적으로 시행됩니다. → **MMR 결과를 치료 시작 전에 확인**하세요.
- 골반 방사선 전 **가임력(정자·난자) 보존** 상담을 받을 수 있는지 물어보세요.
 - 항문에서 가까운 암은 괄약근 보존 가능성과 **임시·영구 장루** 가능성을 수술 전에 설명 듣습니다.

단기 vs 장기 방사선

비교	단기(5회)	장기(5~6주, 항암 병용)
통원	1주	5~6주 매일
이후	대개 항암 이어서	항암 전후
장기 보존(비수술) 목표	병원·상황별	고려되는 경우가 많음

비수술 추적을 고려한다면

- ☐ 이 병원에 비수술 관리 경험이 있나요?
- ☐ 처음 2년은 몇 개월 간격으로 MRI·내시경을 받는다는 일정에 동의하나요?
- ☐ 재성장하면 수술로 전환한다는 계획을 이해했나요?

8장. 수술과 장루

30초 요약: 장루는 대부분 **임시(회장루)**이며 몇 달 뒤 닫는 수술을 합니다. 영구 장루라도 일상·운동·여행이 가능합니다. **장루전문간호사**와 수술 전에 위치를 표시하고 교육을 받으세요.

- 직장암 수술 뒤에는 잦은 변·급박변(저위전방절제증후군, LARS)이 생길 수 있습니다. 골반저 재활·식이·약으로 좋아질 수 있습니다. 대개 수술 후 6개월쯤 크게 나아지고 이후 2년 정도에 걸쳐 조금씩 더 좋아지지만, 수술 전과 똑같아지지는 않아 일부 불편이 남을 수 있습니다.

장루 생활 Q&A

- **냄새·새는 것?** 맞는 용품과 피부 보호제로 대부분 해결됩니다. 피부가 짓무르면 장루전문간호사에게.
- **목욕·수영?** 가능합니다. 방수 용품을 쓰세요.

- **음식?** 회장루는 수분·염분을 충분히, 섬유질 많은 음식(옥수수·버섯 등)은 잘게.
- **옷·운동?** 대부분 평소대로. 무거운 물건은 탈장 예방을 위해 상의.
- **관계·성생활?** 흔한 걱정입니다. 장루 환우회·상담을 이용하세요.

제도

- 장루 용품 지원, 장루·요루 장애 등록은 기준과 판정 시점이 정해져 있습니다 (2026.10 기준·공단·주민센터 확인).

9장. 전이성 대장암

30초 요약: 바이오마커와 **원발 위치(좌/우)**에 따라 치료 조합이 달라집니다. 간·폐 전이가 적으면 **전이 절제**로 완치를 목표로 하는 경우도 있습니다.

상황	범주(국내 허가·급여 확인 필요)
MSI-H/dMMR	면역치료 중심
RAS·BRAF 야생형 + 좌측	항암 + 항EGFR 항체
우측 또는 RAS 변이	항암 + 항VEGF(혈관신생억제)
BRAF V600E	표적 병용
HER2 증폭, KRAS G12C, NTRK	해당 표적 범주
간·폐 전이 소수	절제·소작·SBRT로 근치 목표 가능

국내 급여 참고(2026년 8월 국내 공공 암정보 기준, 바뀔 수 있음): 항VEGF 항체는 RAS 결과와 관계없이 1·2차에서, 항EGFR 항체는 RAS 야생형 1차에서 정해진 항암 조합과 함께 쓸 때 급여가 됩니다. 일부 새 약은 아직 급여 협상 중이라 비용 차이가 클 수 있으니 처방 전에 원무과에 확인하세요.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 대장암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 조직검사·위치 ☐ 진료팀 예약 ☐ 가임력 희망 메모 ☐ 연락처 저장 ☐ 산정특례 문의

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ CT·골반 MRI·CEA ☐ MMR/MSI 의뢰 ☐ 가족력·유전상담 ☐ 가임력 상담 예약

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 병기·MMR 결과 ☐ 수술 먼저 vs 선행치료 ☐ 장루 가능성 설명 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술: 장루 위치 표시·교육, 장 정결 ☐ 선행치료: 모의치료·포트 ☐ 직장 일정

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 ☐ 증상·배변 일지 ☐ 탈수·발열 연락 기준 ☐ 보험 서류
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

배변·신체상·운동

30초 요약: 배변 변화와 장루로 외출·관계가 두려워지는 것은 흔한 반응입니다. 장루전문간호사·환우회와 이야기할 수 있습니다. 꾸준한 신체활동은 재발 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다는 연구가 있습니다.

- 수술 전: 걷기·호흡 운동. 수술 후: 걷기부터, 복부 힘주는 운동은 상의 후.
- 항암 중: 할 수 있는 만큼. 장루가 있으면 복대·탈장 주의.
- LARS: 식사 일기로 유발 음식 찾기, 섬유질 조절, 골반저 재활, 약물.

추적

항목	일반적 예시(병기에 따라)
진찰·CEA	처음 2년 3~6개월마다, 이후 6개월마다(5년까지)
CT	2~3기 이상 처음 몇 년간 6~12개월마다
대장내시경	수술 1년 후, 이후 결과에 따라
직장암 비수술 추적	더 촘촘한 MRI·내시경

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진· 건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(대장암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

대장암 참고: 질병코드는 결장 C18, 직장구불결장 이행부 C19, 직장 C20입니다. 용종 안의 조기암은 진단명(제자리암 vs 침윤암)에 따라 보험 진단비가 다를 수 있어 최종 병리 후 청구하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 결장암인가요, 직장암인가요? 위치는요? 2. 병기와 림프절 상태는요? 3. MMR/MSI 결과는요? 유전상담이 필요한가요? 4. 수술 먼저인가요, 수술 전 치료 먼저인가요? 5. 장루 가능성은? 임시인가요, 영구인가요? 6. 보조항암은 몇 개월인가요? 7. 직장암이라면 비수술 추적이 가능한가요? 8. 가임력 보존 상담을 받을 수 있나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요? 10. 전이가 있다면 RAS·BRAF·HER2 결과는요?

내 대장암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	결장(우/좌) / 직장(항문에서 ____cm)
병기	임상 _ → 병리 _
MMR/MSI	_____
RAS/BRAF/HER2	_____
CEA	_____
첫 치료	수술 / TNT / 면역치료 / 전신치료
장루	없음 / 임시 / 영구
가임력	해당 없음 / 상담

항목	내 기록
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① MMR 결과는? ② 수술이 먼저인가요? ③ 장루와 가임력은?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

58세 병수 씨 — 결장암 3기 "3개월이냐 6개월이냐"를 물었더니, 담당의는 재발 위험과 약 조합을 함께 설명했다. 손발 저림 점검표를 쓰며 주기마다 상태를 말했다. "제가 기록한 걸로 용량을 조절하니, 치료에 참여하는 느낌이었어요."

49세 미영 씨 — 직장암 국소진행 가장 큰 두려움은 장루였다. 장루전문간호사를 수술 전에 만나 위치를 표시하고, 임시 장루라는 설명을 들었다. MMR 결과를 먼저 확인한 덕에 치료 계획이 한 번에 정리됐다. "모르는 게 무서웠던 거더라고요."

39세 준호 씨 — 린치증후군 의심, 형제 있음 유전상담 후 배선 검사에서 변이가 확인됐다. 형제들에게 보낼 문자를 상담사와 함께 다듬었다. "가족을 걱정시킨다고 생각했는데, 미리 검진하게 해 준 거라고 생각하기로 했어요."

용어사전

용어	쉬운 뜻
결장 / 직장	대장의 대부분 / 항문 가까운 마지막 부분
MMR / MSI	DNA 수선 단백질 / 그 결함의 결과
린치증후군	대장암 등 위험을 높이는 유전 질환
TNT(전체 선행치료)	항암과 방사선을 모두 수술 전에 하는 방식

용어	쉬운 뜻
임상적 완전관해	검사상 종양이 보이지 않는 상태
비수술 추적	수술 없이 촘촘히 검사하며 지켜보는 전략
장루(회장루·결장루)	장을 배 밖으로 내어 변을 받는 구멍
LARS	직장 수술 후 잦은 변·급박변
CEA	추적에 쓰는 혈액 표지자
항EGFR / 항VEGF	전이성에서 쓰는 표적 항체 범주

자주 묻는 질문 12

Q1. 장루는 꼭 하게 되나요? 결장암은 대부분 장루 없이 수술합니다. 직장암, 특히 항문 가까운 경우 임시 장루가 흔하고, 영구 장루는 일부입니다. 수술 전에 가능성을 물어보세요.

Q2. 임시 장루는 언제 닫나요? 보통 수술 후 수개월 뒤, 항암이 끝난 뒤 닫는 경우가 많습니다. 일정은 병원에 따라 다릅니다.

Q3. CEA가 정상인데 암이 맞나요? CEA는 진단 검사가 아니라 추적 표지자입니다. 정상이어도 암일 수 있습니다.

Q4. 보조항암은 3개월만 하면 안 되나요? 재발 위험과 약 조합에 따라 3개월이 가능한 경우가 있습니다. 내 위험도에서 3개월과 6개월의 차이를 물어보세요.

Q5. 손발 저림은 회복되나요? 많은 경우 항암 종료 후 수개월에 걸쳐 좋아지지만, 일부는 오래 남을 수 있습니다. 그래서 일상에 영향을 주기 시작하면 바로 알려 용량을 조절하는 것이 중요합니다.

Q6. 직장암인데 수술을 안 할 수도 있나요? 수술 전 치료 후 종양이 사라지면 비수술 추적을 상의할 수 있고, dMMR 직장암은 면역치료로 수술을 피하는 경우가 있습니다. 경험 많은 센터와 상의하세요.

Q7. 수술 후 화장실을 너무 자주 가요. 직장 수술 후 흔한 증상(LARS)입니다. 식이 조절·골반저 재활·약으로 좋아질 수 있지만 오래가는 경우도 있으니 알려세요.

Q8. 고기는 먹으면 안 되나요? 가공육·붉은 고기를 줄이는 것이 일반 권고이지만, 치료 중에는 단백질 섭취가 중요합니다. 생선·달걀·두부·살코기를 고루 드세요.

Q9. 가족도 대장내시경을 받아야 하나요? 부모·형제·자녀 중 대장암이 있으면 더 일찍(보통 40세 또는 가족 진단 나이보다 10년 일찍) 대장내시경을 권하는 경우가 많습니다. 린치증후군이면 더 자주 받습니다. 국가 대장암 검진은 현재 50세 이상 매년 분변잠혈검사(양성이면 대장내시경)이며, 대장내시경을 1차 검사로 바꾸는 방안이 2028년 시행 목표로 추진되고 있습니다(시행 여부 확인).

Q10. 간에 전이가 있으면 수술이 불가능한가요? 전이가 적으면 간 절제나 소작으로 완치를 목표로 하는 경우가 있습니다. 대장암 전이 수술 경험이 많은 센터와 상의하세요.

Q11. 장루가 있으면 운동·여행이 가능한가요? 가능합니다. 복부에 무리가 가는 운동은 탈장 예방을 위해 상의하고, 여행 시 용품을 넉넉히 챙기세요.

Q12. 젊은 나이에 대장암에 걸린 이유가 있나요? 최근 젊은 대장암이 늘고 있으며 원인은 연구 중입니다. 50세 이전 진단이면 유전상담을 받는 것이 좋습니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전달

- □ 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- □ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- □ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

- 1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
- 2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
- 3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
- 4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
- 5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 먼저 의료진에게 양해를 구하세요. 허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	

항목	기록
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(🕒)
1주(Day 0-7)		

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Colon Cancer / Rectal Cancer, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 대장암 정보, 대한대장항문학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례·장애 등록 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 대장암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
 - 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>